

Cómo Armar un Plan de Tratamiento

Guía paso a paso con fundamento en TCC, modelos de formulación clínica y psicología basada en evidencia

El plan de tratamiento es el mapa del proceso terapéutico. Desde la Terapia Cognitivo-Conductual (Beck, 1979; Persons, 2008) y los modelos de formulación de caso (Kuyken, Padesky & Dudley, 2009), se sostiene que un tratamiento estructurado mejora significativamente los resultados clínicos, aumenta la adherencia y reduce la posibilidad de estancamiento.

¿Por qué un plan de tratamiento?

La evidencia muestra que los tratamientos estructurados con objetivos claros producen mejores resultados que los no estructurados. La formulación de caso permite personalizar las intervenciones, reducir el tiempo de tratamiento y anticipar obstáculos (Persons & Tompkins, 2007).

PASO 1 — Formulación o Diagnóstico Funcional

La formulación de caso es el eje central del tratamiento en TCC. A diferencia del diagnóstico categorial del DSM/CIE, la formulación funcional busca comprender **por qué** este paciente tiene este problema en este momento. El modelo de Kuyken, Padesky y Dudley (2009) plantea la formulación en tres niveles: descriptivo, explicativo e inferencial.

COMPONENTE	QUÉ EVALUÁS	HERRAMIENTAS
Factores predisponentes	Historia personal, aprendizajes tempranos, vulnerabilidades	Entrevista clínica, historia vital
Factores precipitantes	Evento o contexto que desencadenó el problema actual	Línea de tiempo, análisis funcional
Factores mantenedores	Conductas de evitación, sesgos cognitivos, refuerzos	Autorregistros, análisis ABC
Recursos y fortalezas	Habilidades, vínculos, motivación al cambio	Entrevista motivacional, escalas

■ *Nota clínica: El modelo ABC de Ellis y el análisis funcional de Skinner son complementarios: uno trabaja los mediadores cognitivos y el otro las contingencias conductuales. Usados juntos, dan una imagen completa del problema.*

■ Kuyken, W., Padesky, C.A. & Dudley, R. (2009). *Collaborative Case Conceptualization*. Guilford Press.

■ Persons, J.B. (2008). *The Case Formulation Approach to Cognitive-Behavior Therapy*. Guilford Press.

PASO 2 — Objetivos Terapéuticos

En TCC y en los modelos de tercera ola (ACT, DBT), los objetivos terapéuticos tienen una función central: orientan las intervenciones, aumentan la motivación del paciente y permiten evaluar el progreso. Desde la perspectiva de la Entrevista Motivacional (Miller & Rollnick, 2002), el paciente tiene más probabilidades de comprometerse con objetivos que él mismo formuló.

Objetivos a largo plazo (metas):

Cambios generales que el paciente quiere lograr. Ej: "Mejorar mis vínculos afectivos" o "Reducir el impacto de la ansiedad en mi vida".

Objetivos a mediano plazo:

Pasos intermedios hacia la meta. Ej: "Identificar los patrones relacionales disfuncionales" o "Aprender a regular la activación fisiológica".

Objetivos a corto plazo / de sesión:

Lo que se trabaja en cada encuentro. Ej: "Practicar la técnica de reestructuración cognitiva con el evento de esta semana".

■ *Nota clínica: Los objetivos bien formulados son SMART: Específicos, Medibles, Alcanzables, Relevantes y con Tiempo definido. Adaptado de la psicología organizacional al contexto clínico por Persons (2008).*

Preguntas para co-construir objetivos en sesión:

→ "¿Qué te gustaría que sea diferente en tu vida cuando terminemos de trabajar juntos?"

→ "Si la terapia funcionara perfectamente, ¿cómo te verías en un año?"

→ "¿Qué es lo que más limita tu funcionamiento cotidiano hoy?"

→ "¿Cómo vamos a saber que estamos avanzando? ¿Qué vas a poder hacer diferente?"

→ "¿Hay algo que estás evitando hacer por este problema?" (clave para TCC)

■ Miller, W.R. & Rollnick, S. (2002). *Motivational Interviewing*. Guilford Press.

PASO 3 — Selección de Técnicas y Estrategias

La elección de técnicas debe basarse en la formulación de caso y en la evidencia disponible para cada problemática, no en las preferencias del terapeuta. La APA Task Force on Evidence-Based Practice (2006) establece que el tratamiento debe integrar la mejor evidencia disponible con la experticia clínica y las preferencias del paciente.

PROBLEMÁTICA	TÉCNICAS CON EVIDENCIA	MODELO DE REFERENCIA
Trastornos de ansiedad	Exposición gradual, reestructuración cognitiva, relajación, psicoeducación	TCC (Clark & Beck, 2010)
Depresión	Activación conductual, registro de pensamientos, resolución de problemas	TCC (Beck, 1979; Martell, 2001)

Desregulación emocional	Habilidades TIPP, mindfulness, tolerancia al malestar	DBT (Linehan, 1993)
Evitación experiencial	Defusión cognitiva, valores, acción comprometida	ACT (Hayes, 2004)
Problemas interpersonales	Entrenamiento en asertividad, DEAR MAN, análisis de patrones	DBT / Terapia Interpersonal

■ *Nota clínica: Primero formulá el caso, luego elegí la técnica. Las técnicas aplicadas sin formulación pueden ser contraproducentes — especialmente la exposición en casos con trauma no elaborado.*

■ APA Task Force on Evidence-Based Practice (2006). *Evidence-based practice in psychology*. *American Psychologist*, 61(4), 271-285.

PASO 4 — Revisión y Ajuste del Plan

El plan de tratamiento es un documento dinámico. En TCC se recomienda una revisión sistemática cada 8-12 semanas o ante cambios significativos en el paciente o su contexto. Lambert et al. (2003) demostraron que el monitoreo regular del progreso reduce significativamente las tasas de abandono y mejora los resultados.

✓ ¿Estamos avanzando hacia los objetivos?	Usá escalas breves (PHQ-9, GAD-7, BDI) o simplemente pedile al paciente que puntúe su estado del 1 al 10. La medición sistemática permite detectar estancamientos temprano.
✓ ¿Los objetivos siguen siendo relevantes?	Los objetivos pueden cambiar a medida que el paciente progresa o que emergen nuevas problemáticas. Revisarlos no es señal de fracaso — es parte del proceso.
✓ ¿Las técnicas están funcionando?	Si una técnica no produce cambio luego de 3-4 sesiones aplicada correctamente, es momento de replantear. Puede indicar que la formulación necesita revisión.
✓ ¿Hay obstáculos al cambio?	Resistencia, falta de adherencia a tareas o dificultades externas son información clínica. Trabajalos en sesión antes de avanzar con nuevas técnicas.

■ Lambert, M.J. et al. (2003). *Is it time for clinicians to routinely track patient outcome? A meta-analysis*. *Clinical Psychology*, 10(3), 288-301.

RESUMEN: Plan de Tratamiento en 4 Pasos

PASO	COMPONENTE	CUÁNDO	FUNDAMENTO
01	Formulación / Diagnóstico Funcional	Sesiones 1-3	Kuyken et al. (2009)
02	Objetivos Terapéuticos (corto, mediano, largo)	Sesiones 2-4	Persons (2008), Miller & Rollnick (2002)

03	Técnicas y Estrategias basadas en evidencia	A partir de sesión 3-4	APA EBP Guidelines (2006)
04	Revisión y Ajuste sistemático	Cada 8-12 semanas	Lambert et al. (2003)

© quieroterapia.com.ar | Recurso clínico de uso exclusivo para miembras de la plataforma | Basado en evidencia científica